Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области
«Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер»
(ГБУЗ МО «МОКПТД»)

ПРИКАЗ

«15» января 2026 № 15/26

О централизованном контроле за диспансерным наблюдением, лечением больных туберкулезом и контролем за оформлением свидетельств о смерти от туберкулеза в Московской области

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2003 № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации»; приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 г. № 127н «Об утверждении порядка диспансерного наблюдения за больными туберкулезом, лицами, находящимися в контакте с источником туберкулеза, а так же лицами с подозрением на туберкулез»; приказом Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2012 № 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 932н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.02.2004 № 50 «О введении в действие учетной и отчетной документации мониторинга туберкулеза», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.04.2014 № 951 «Об утверждении методических рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечению туберкулеза органов дыхания», с клиническими рекомендациями «Туберкулез у взрослых», 2024г., «Туберкулез у детей», 2024г., в целях совершенствования организации оказания медицинской помощи больным туберкулёзом на территории Московской области путем централизованного контроля за выявлением, диагностикой, эффективностью лечения на всех этапах наблюдения, разбора случаев смерти от туберкулеза и выявления ее причин,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

- состав Центральной врачебной комиссии (далее - ЦВК) Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер» (далее - ГБУЗ МО «МОКПТД», ее подкомиссий (Приложение 1);
- положение о ЦВК и ее подкомиссий (Приложение 2);
- план-график работы ЦВК (Приложение 3);
- унифицированные формы:
- форму бланка эпикриза больных туберкулезом взрослых для представления на ЦВК (Приложение 4),
- форму бланка эпикриза для детей и подростков (Приложение 5);
- форму протокола заседания ЦВК для взрослых и детей (Приложение 6);
- форму журнала заседаний ЦВК для взрослых и детей (Приложение 7);
- форму протокола разбора случая смерти от туберкулеза (Приложение 8);
- форму журнала регистрации случаев смерти пациентов от туберкулёза (Приложение 9);
- список филиалов и их отделений ГБУЗ МО «МОКПТД», а также противотуберкулёзных отделений и кабинетов, входящих в состав медицинских организаций Московской области (Приложение 10);
- формы отчетов о деятельности ЦВК ГБУЗ МО «МОКПТД» (Приложение 11);

3. Возложить ответственность за использование унифицированных форм на руководителей филиалов, в том числе филиала «Балашихинский», в состав которого на 2026 год вошли стационарные отделения, Клиники №1, Клиники №2 ГБУЗ МО «МОКПТД».

4. Признать утратившими силу приказ ГБУЗ МО «МОКПТД» от 16.01.2025 № 15/25 «О централизованном контроле за диспансерным наблюдением, лечением больных туберкулезом и контролем за оформлением свидетельств о смерти от туберкулеза в Московской области»

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач С.В. Смердин

Приложение 1
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «15» января 2026 г. № 15/26

СОСТАВ ЦВК ГБУЗ МО «МОКПТД»

Председатель: Баронова О.Д., д.м.н., заместитель главного врача по медицинской помощи в амбулаторных условиях.
Заместитель председателя: Воробьева Т.И. – заведующая клинико-диагностическим отделением ГБУЗ МО «МОКПТД» (далее – КДО).
Члены ЦВК:
– Лапырева И.А., заместитель главного врача по медицинской части;
– Горбунова Е.В., заместитель главного врача по клинико-экспертной работе;
– Плеханова М.А., д.м.н. заместитель главного врача по научной работе;
– Тощевиков М.В., заместитель главного врача по хирургической помощи;
– Фролов Е.Г., заместитель главного врача по организационно-методической работе;
– Багдасарян Т.Р., к.м.н., заведующая клиникой № 1, врач-фтизиатр;
– Ильина О.С., заведующая клиникой № 2;
– Смирнов В.Ю., заместитель заведующего по медицинской части филиала «Балашихинский» ГБУЗ МО «МОКПТД»;
– Зебницкая И. С., заместитель заведующего Клиникой № 1 по клинико-экспертной работе (далее – КЭР);
– Тимакова Ю.И., заместитель заведующего Клиникой № 1 по медицинской части, врач-фтизиатр;
– Унтанова Л.С., к.м.н, заведующий организационно-методическим отделом ГБУЗ МО «МОКПТД» (далее – ОМО);
– Мильянкова В.Р., врач-фтизиатр КДО;
– Елуфимова Е.И., врач-фтизиатр КДО;
– Федорова С.В., врач-фтизиатр КДО;
– Алиева И.А., врач-фтизиатр КДО;
– Арутюнова М.А., врач-фтизиатр КДО;
– Кузнецова Е.В., врач-фтизиатр КДО;
– Никитина Е.С., заместитель заведующего Клиникой № 2, врач-фтизиатр;
– Панасюк В.И., врач-фтизиатр ОМО;
– Терехова Н.Г., врач-фтизиатр клинико-экспертного отдела;
– Саранчина С.В., врач-фтизиатр ОМО;
- Гончаревич А.Е., заведующий отделением лучевой диагностики Клиники № 1, врач-рентгенолог;
– Лобанов Е.Г., врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики КДО;
– Евлоева Я.Х., заведующая кабинетом лучевой диагностики КДО;
– Филиппова Е.В., врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики Клиники № 1.

Секретари ЦВК:

– Горлова С.В., врач-фтизиатр КДО;
– Гриценко Е.Ю., врач-фтизиатр КДО.

СОСТАВ ПОДКОМИССИИ ЦВК ПО РАЗБОРУ СЛУЧАЕВ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Председатель: Баронова О.Д., д.м.н., заместитель главного врача по медицинской помощи в амбулаторных условиях.
Заместитель председателя: Воробьева Т.И., заведующая КДО.
Члены подкомиссии:
– Плеханова М.А., д.м.н., заместитель главного врача по научной работе;
– Мильянкова В.Р., врач-фтизиатр КДО;
– Елуфимова Е.И., врач-фтизиатр КДО;
– Федорова С.В., врач-фтизиатр КДО;
– Евлоева Я.Х., врач-рентгенолог, заведующая кабинетом лучевой диагностики КДО.

Секретарь врачебной подкомиссии: Алиева И.А., врач-фтизиатр КДО.

СОСТАВ ПОДКОМИССИИ ЦВК ПО РАЗБОРУ ВНЕЛЕГОЧНЫХ ФОРМ ТУБЕРКУЛЕЗА

– Председатель: Тощевиков М.В., заместитель главного врача по хирургической помощи.
– Заместитель председателя: Подкосов И.В., заведующий хирургическим отделением для больных костно-суставным туберкулезом и прочих внелегочных локализаций хирургического отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации № 2 Клиники № 1, врач-травматолог-ортопед; врач ортопед-травматолог.
Члены подкомиссии:
– Жиленков С.Г., врач-травматолог-ортопед; врач ортопед-травматолог.
Члены:
– Лапырева И.А., заместитель главного врача по медицинской части;
– Багдасарян Т.Р., к.м.н., заведующая Клиникой № 1, врач-фтизиатр;
– Горбунова Е.В., заместитель главного врача по КЭР;
– Зебницкая И. С., заместитель заведующего Клиникой № 1 по клинико-экспертной работе КЭР;
– Пятов Д.Л., заведующий хирургического отделения для больных туберкулезом внелегочных локализаций сочетанными с ВИЧ-инфекцией;
– Гончаревич А.Е., заведующий отделением лучевой диагностики Клиники № 1, врач-рентгенолог;
– Филиппова Е.В., врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики Клиники № 1.
Секретарь врачебной подкомиссии: Нивестюк А.Е., врач-уролог.

СОСТАВ ПОДКОМИССИИ

ПО РАЗБОРУ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ

Председатель: Фролов Е.Г., заместитель главного врача по организационно-методической работе;
Заместитель председателя: Унтанова Л.С., к.м.н., врач-фтизиатр, заведующая ОМО,
Члены:
– Баронова О.Д., д.м.н., заместитель главного врача по медицинской помощи в амбулаторных условиях;
– Лапырева И.А., заместитель главного врача по медицинской части;
– Воробьева Т.И., врач-фтизиатр, заведующая КДО;
– Горбунова Е.В., заместитель главного врача по КЭР;
– Терехова Н.Д., врач-фтизиатр клинико-экспертного отдела;
– Панасюк В.И., врач-фтизиатр ОМО.

Секретарь врачебной подкомиссии: Саранчина С.В., врач-фтизиатр ОМО.

Приложение 2
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «15» января 2026 г. № 15/26

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОТЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ (ЦВК) ГБУЗ МО «МОКПТД»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Центральная врачебная комиссия (далее – «ЦВК») создана в целях совершенствования выявления, диагностики и лечения больных туберкулезом, а также регистрации случаев туберкулеза или снятия диагноза «туберкулёз», оценки эффективности лечения больных туберкулезом.

2. ЦВК проводит разбор летальных случаев больных туберкулезом с выявлением причин смерти и обсуждением противоэпидемических мероприятий в очаге туберкулезной инфекции.

3. Деятельность ЦВК связана с курацией территорий. Во время визитов в районы кураторы контролируют работу по выявлению и диагностике туберкулеза, своевременность предоставления информации о выявленных больных туберкулезом и выполнение решений ЦВК, осуществляют контроль за лечением.

4. Состав ЦВК утверждается приказом ГБУЗ МО «МОКПТД».

5. Комиссия состоит из председателя, нескольких заместителей председателя (по направлениям их деятельности), секретаря и членов комиссии.

6. Состав и регламент комиссии ГБУЗ МО «МОКПТД» утверждается главным врачом. Председателям комиссий назначается наиболее подготовленный специалист, в должностные обязанности которых входят решения вопросов, отнесенные к компетенции комиссии.

7. Председатель комиссии и его заместители несут ответственность за деятельность комиссии.

8. Заседания комиссии проводятся по определенному графику. В случае необходимости по решению руководителя медицинской организации или председателя комиссии могут проводится внеплановые заседания.

ФУНКЦИИ ЦВК ГБУЗ МО «МОКПТД»

Основными функциями комиссии являются:

1. Централизованный контроль установления диагноза активного туберкулеза и взятия под диспансерное наблюдение

1.1. Регистрация впервые выявленных больных туберкулезом и больных с рецидивами туберкулеза органов дыхания;

1.2. Подтверждение либо снятие диагноза туберкулеза у пациентов, ранее взятых на учет;

1.3. Рассмотрение сложных и спорных диагностических случаев, случаев лечения и диспансерного наблюдения больных туберкулезом;

1.4. Допуск к труду декретированных лиц (до завершения основного курса

лечения и по результатам эффективно завершенного курса лечения);

1.5. Перевод во 2А группу.

1.6. Перевод во 2Б группу с изменением ранее установленной клинической формы на фиброзно-кавернозную форму туберкулеза осуществляется только по решению ЦВК;

1.7. Контроль диагностики, регистрации и лечения детей и подростков с впервые выявленным туберкулезом или рецидивом туберкулеза различных локализаций, а также рассмотрение всех случаев взятия детей под диспансерное наблюдение по V и VI Б ГДН осуществляет подкомиссия по туберкулезу у детей и подростков;

1.8. Контроль диагностики, регистрации и лечения всех впервые выявленных больных туберкулезом или с рецидивами туберкулеза с внелегочной локализацией осуществляет подкомиссия по внелегочному туберкулезу.

2. Централизованный контроль за лечением больных туберкулезом различных локализаций

2.1. Регистрация пациентов для назначения лекарственно-чувствительных режимов химиотерапии (далее – РХТ);

2.1.2. Своевременное внесение корректив в лечение впервые выявленных больных, больных с рецидивами без деструкций в легких в случае отсутствия положительной клинико-рентгенологической динамики или отрицательной рентгенологической динамике, при сохранении или появлении бактериовыделения через 60 суточных доз при условии, что лечение по лекарственно-чувствительных РХТ проводилось под контролем;

2.1.3. Своевременное внесение корректив в лечение впервые выявленных больных, больных с рецидивами при отрицательной рентгенологической динамике, сохранении полости распада и бактериовыделения после приема 90 суточных доз ПТП при условии, что лечение по лекарственно-чувствительных РХТ проводилось под контролем;

2.1.4. При сохранении бактериовыделения или появления отрицательной рентгенологической динамики в сроки 120-150 доз (до момента предельной продолжительности интенсивной фазы химиотерапии) в обязательном порядке представлять протокол на заседание ЦВК **для перерегистрации на режимы терапии лекарственно-устойчивого туберкулеза (режим МЛУ).**

2.1.5. Определение эффективности лечения у больных туберкулезом, имевших при регистрации полость распада и (или) бактериовыделения, лечение которых проводилось по лекарственно-чувствительным РХТ (по показателям абациллирования, рубцевания деструкций в легких).

2.1.6. Оценка в срок до 12 календарных месяцев эффективности основного курса лечения по лекарственно-чувствительным РХТ с последующим переводом в III ГДН; рассмотрение вопроса о лечении по лекарственно-чувствительным режимам свыше 12 месяцев.

2.2. Регистрация пациентов для назначения режимов химиотерапии МЛУ-ТБ, пре-ШЛУ-ТБ, ШЛУ-ТБ (IV-V РХТ), перевод в фазу продолжения после окончания интенсивной фазы лечения по IV-V РХТ.

2.2.1.Своевременное внесение корректив в лечение пациентов с МЛУ МБТ, пре-ШЛУ МБТ, ШЛУ МБТ при отсутствии рентгенологической динамики, сохранении полости распада и бактериовыделения после приема 180 суточных доз ПТП при условии, что лечение по лекарственно-устойчивым РХТ проводилось под контролем;

2.2.2.Определение эффективности лечения у больных, получавших химиотерапию по IV и V РХТ (по показателям абациллирования, рубцевания деструкций в легких).

2.2.3. Оценка в срок до 24 календарных месяцев эффективности основного курса лечения по IV и V РХТ с последующим переводом в III ГДН; рассмотрение вопроса о лечении по IV-V РХТ свыше 24 месяцев.

2.2.4. Определение тактики ведения пациентов с МЛУ МБТ, пре-ШЛУ МБТ, ШЛУ МБТ с хроническими формами туберкулеза без перспективы на излечение и не приверженных к лечению.

2.2.5. Назначение противотуберкулезных препаратов второго ряда таких как бедаквилин, деламанид, клофаземин до 180 доз, а также продление курса бедаквилина, деламанида свыше 180 доз при условии информированного согласия пациента.

2.2.6. Регистрация пациентов для амбулаторного лечения по режимам химиотерапии МЛУ-ТБ, пре-ШЛУ-ТБ, ШЛУ-ТБ (IV-V РХТ) в интенсивной фазе и/или фазе продолжения с выдачей лекарственных препаратов с использованием *видеоконтроля* за приемом препаратов;

2.2.7. Регистрация больных на эмпирический режим химиотерапии МЛУ-ТБ по клиническим показаниям при отсутствии положительных результатов этиологических исследований, подтверждающих МЛУ МБТ.

2.2.8. В случае получения разнонаправленных результатов этиологических исследований окончательное решение о режиме химиотерапии принимается центральной врачебной комиссией с учетом динамических результатов клинико-рентгенологического мониторинга.

3. Централизованный контроль за лечением больных туберкулезом с использованием хирургических методов лечения и коллапсотерапии

3.1. Решение вопроса о возможности и сроках проведения хирургического вмешательства с участием врача-торакального хирурга в первые два месяца от начала этиотропной терапии;

3.2. Решение вопроса о возможности и сроках проведения коллапсотерапии (искусственный пневмоперитонеум), а также эндоскопической клапанной бронхоблокации в первые два месяца от начала этиотропной терапии.

4. Централизованный контроль за оформлением свидетельств о смерти

4.1. Осуществление текущего контроля за оформлением свидетельств о смерти.

4.2. Проведение коллегиальных разборов каждого случая смерти от туберкулеза с выявлением причин в целях повышения достоверности показателя смертности.

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЦВК

1. Противотуберкулезные кабинеты, отделения медицинских организаций Московской области при отсутствии состава ВК в противотуберкулезном отделении (кабинете) медицинского учреждения, перед рассмотрением на ЦВК направляют больных на консультацию в ГБУЗ МО «МОКПТД» к врачу-фтизиатру, куратору территории на очную консультацию, или представляют заочно на электронный адрес центральной врачебной комиссии: **mz_mokptd_cvkk@mosreg.ru**

2. . Сведения о плане-графике работы ЦВК и ответственных за курацию территорий Московской области отражены в приложении 3, 11.

3. Для заочной консультации необходимо представить: результаты рентгенологического обследования, компьютерного томографического исследования пораженного органа (изображение) на электронном или пленочном носителе, выписку из медицинской карты амбулаторного или стационарного больного, анализы мокроты на МБТ, анализы крови, мочи, результаты внутрикожных проб или лабораторных IGRA-тестов, эпидемиологический анамнез, форму № 089Т/У.

4. Представление на ЦВК впервые выявленных пациентов и пациентов с рецидивом туберкулеза обеспечивают специалисты филиалов ГБУЗ МО «МОКПТД» (далее - филиал) по территориальному принципу или противотуберкулезных кабинетов (отделений). При установлении диагноза впервые выявленного случая или рецидива туберкулеза в диагностическом отделении стационара медицинскую документацию представляет на ЦВК врач-фтизиатр стационарного отделения, курирующий пациента.

5. С целью регистрации режимов химиотерапии представление медицинской документации проводится врачами-фтизиатрами филиала (противотуберкулезного кабинета (отделения) или стационарного отделения. Направление на ЦВК осуществляется после получения результатов ТЛЧ, по решению врачебной комиссии.

6. Представление медицинской документации для оценки эффективности проведенного курса лечения, перевода в III ГДН при условии лечения по IV-V РХТ проводит филиал, осуществляющий диспансерное наблюдение.

7. Подтверждения диагноза «Фиброзно-кавернозный туберкулез легких» на заседании ЦВК может осуществляться врачами стационарных или амбулаторных отделений.

8. На рассмотрение комиссии представляют следующую документацию:

1. Для регистрации диагноза туберкулеза у впервые выявленных больных и больных с рецидивами туберкулеза на ЦВК «МОКПТД»: форма 089/туб, подробный эпикриз с данными из амбулаторной карты больного с решением ВК, подкомиссии ВК (приложение 4, 5, 6), форма № 01-ТБ/У или Форма № 501/У из ФРБТ, Форма

№ 502/У из ФРБТ (МЛУ/ШЛУ) ретроспективный анализ рентгенологического обследования, оформленный протокол ЦВК.

2. Для определения эффективности лечения больного: подробный эпикриз с данными из амбулаторной карты больного с решением ВК, подкомиссии ВК (приложение 4,5,6), бактериограмма, заполненная форма № 01-ТБ/У или Форма № 501/У из ФРБТ, Форма № 502/У из ФРБТ (МЛУ/ШЛУ), количество принятых доз, схема лечения, рентгенологический архив.

3. Для рассмотрения сложных случаев и спорных случаев лечения и (или) наблюдения больного: протокол заседания ВК, подробный эпикриз с данными из амбулаторной карты больного (приложение 4, 5, 6), бактериограмма, заполненная форма № 01-ТБ/У или Форму № 501/У из ФРБТ, форма № 502/У из ФРБТ (МЛУ/ШЛУ) на последний курс лечения, рентгенологический архив.

4. При рассмотрении случаев смерти от туберкулеза представляются форма № 30/У, протокол патологоанатомического вскрытия, протокол КИЛИ, данные гистологического исследования, (в электронном виде и на бумажном носителе) (приложения 8, 9), объяснительная по умершим, неизвестным диспансеру и умершим до одного года наблюдения, а также протокол конференции из поликлиники по месту прикрепления больного с разбором данного случая смерти.

5. Для проведения ЦВК по туберкулезу у детей и подростков представляется выписка из амбулаторной карты с указанием сведений о противотуберкулезной вакцинации и иммунодиагностики за предыдущие годы, амбулаторная карта, форма № 01-ТБ/У или форма № 501/У из ФРБТ, форма № 502/У, рентгенологический архив, СКТ-исследование, а также сведения о рентгенологическом обследовании родителей и близкого окружения заболевшего ребенка.

6. Решение комиссии оформляется протоколом (приложение 6). Оригинал протокола, эпикриз представления должен находиться в медицинской документации представленного пациента. Копия протокола, хранится в ОМО у секретаря ЦВК. Секретарь комиссии вносит принятое решение в журнал (приложение 7).

7. Отчет о деятельности ЦВК формируется 1 раз в месяц, 1 раз в квартал, по итогам календарного года (приложение 11). Форма Журнала регистрации заседаний ЦВК приведена в приложении 7.

Приложение 3
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «15» января 2026 г. № 15/26

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЦВК ГБУЗ МО МОКПТД

Заседания ЦВК ГБУЗ МО «МОКПТД» проводятся в соответствии с приложенным графиком, начало заседания **с 09-00 до 13-00 ч.,** по адресу: г. Москва площадь Борьбы, д 11, стр.1 (КДО); Московская область, г. Мытищи, п. Здравница, ул. Дубки, д.7 (Клиника № 1)

Наименование	Ответственные	День проведения ЦВК
Заседание детской подкомиссии ЦВК	Баронова О.Д., д.м.н., зам.гл.врача по медицинской помощи в амбулаторных условиях, врач-фтизиатр	1;2;3;4 понедельник с 9-00 до 13-00 часов г. Москва, Пл. Борьбы д.11/1 (КДО)
Заседание подкомиссии ЦВК по разбору случаев смерти от туберкулеза	Фролов Е.Г., заместитель главного врача по организационно-методической работе	4 четверг . Москва, Пл. Борьбы д.11/1 (КДО). Время проведения уточняется дополнительно.
Филиал «Подольский» ГБУЗ МО «МОКПТД», в том числе Серпуховское и Чеховское амбулаторные отделения	Заведующий филиалом «Подольский» Михайлова И.В.	Понедельник с 9-00 до 13-00 часов г. Москва, Пл. Борьбы д.11/1 (КДО)
Филиал «Домодедовский» ГБУЗ МО «МОКПТД», в том числе Видновское амбулаторное отделение	Заведующий филиалом «Домодедовский» Кондр Д.Е.	2;4 четверг с 9-00 до 13-00 часов г. Москва, Пл. Борьбы д.11/1 (КДО)
Каширский ПТК ГБУЗ МО «Каширская ЦРБ», Серебряно-Прудский ПТК ГБУЗ МО «Серебряно-Прудская ЦГБ», Ступинское ПТО ГБУЗ МО «Ступинская ГКБ»	Врач-фтизиатр КДО ГБУЗ МО «МОКПТД», куратор территории Гриценко Е.Ю.	2;4 четверг с 9-00 до 13-00 часов г. Москва, Пл. Борьбы д.11/1 (КДО)
Филиал «Коломенский» ГБУЗ МО «МОКПТД», в том числе Егорьевское амбулаторное отделение	Заведующий филиалом «Коломенский» Мануйлов Н.В.	2;4 понедельник с 9-00 до 13-00 часов г. Москва, Пл. Борьбы д.11/1 (КДО)
Озерский ПТК ГБУЗ МО «Озерская ЦРБ», Луховицкий ПТК ГБУЗ МО «Луховицкая ЦРБ», Рошальский ПТК, Шатурский ПТК ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ», Воскресенское ПТО ГБУЗ МО «Воскресенская ГБ», Зарайский ПТК ГБУЗ МО «Зарайская ЦРБ»	Врач-фтизиатр КДО ГБУЗ МО «МОКПТД», куратор территории: Гриценко Е.Ю.,	г. Москва, Пл. Борьбы д. 11/1 (КДО)

Филиал «Люберецкий» ГБУЗ МО «МОКПТД»	Заведующий филиалом «Люберецкий» Воробьёв В.Ю. Врач-фтизиатр КДО ГБУЗ МО «МОКПТД», куратор территории Гриценко Е.Ю.	1;3 вторник с 9-00 до 13-00 часов г. Москва, Пл. Борьбы д.11/1 (КДО)
Филиал «Раменский» ГБУЗ МО «МОКПТД», Бронницкий ПТК ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница»	Заведующий филиалом Жердев А.В. Врач-фтизиатр КДО ГБУЗ МО «МОКПТД», куратор территории Арутюнова М.А.	1;3 понедельник с 9-00 до 13-00 часов г. Москва, Пл. Борьбы д.11/1 (КДО)
Филиал «Клинский» ГБУЗ МО «МОКПТД», в том числе Химкинское диспансерное отделение ГБУЗ МО «Солнечногорская ЦРБ», ПТО ГБУЗ МО «Долгопрудненская ЦГБ», ПТО ГБУЗ МО «Лобненская ЦГБ»	Заведующий филиалом «Клинский» Лукаш И.А. Врач-фтизиатр КДО ГБУЗ МО «МОКПТД», куратор территории Горлова С.В., Кузнецова Е.В.	2;4 понедельник с 9-00 до 13-00 часов г. Москва, Пл. Борьбы д.11/1 (КДО)
Филиал «Сергиево - Посадский» ГБУЗ МО «МОКПТД», в том числе Дмитровское диспансерное отделение, ПТК ГБУЗ МО «Дубненская ГБ», ПТК ГБУЗ МО «Талдомская ЦРБ»	Заведующий филиалом «Сергиево-Посадский» Трошин Н.А. Врач-фтизиатр КДО ГБУЗ МО «МОКПТД», куратор территории Горлова С.В.	1;3 вторник с 9-00 до 13-00 часов г. Москва, Пл. Борьбы д.11/1 (КДО),
Филиал «Орехово - Зуевский» ГБУЗ МО «МОКПТД», в том числе Павловско - Посадское амбулаторное отделение	Заведующий филиалом «Орехово-Зуевский» Гордеев А.А. Врач-фтизиатр КДО ГБУЗ МО «МОКПТД», куратор территории Арутюнова М.А.	1;3 вторник с 9-00 до 13-00 часов г. Москва, Пл. Борьбы д.11/1 (КДО),
Филиал «Мытищинский» ГБУЗ МО «МОКПТД», в том числе Щелковское амбулаторное отделение, Королевское амбулаторное отделение, Пушкинское амбулаторное отделение Ивантеевский ПТК ГБУЗ МО «Ивантеевская ЦГБ», Фрязинский ПТК ГАУЗ МО «ЦГБ им. М.В. Гольца», Красноармейский ПТК ФГБУЗ МСЧ № 154 ФМБА России	Заведующий филиалом «Мытищинский» Тушева И. А. Врач-фтизиатр КДО ГБУЗ МО «МОКПТД», куратор территории Горлова С.В.	2;4 вторник с 9-00 до 13-00 часов г. Москва, Пл. Борьбы д.11/1 (КДО)
Филиал «Истринский» ГБУЗ МО «МОКПТД», в т.ч. Волоколамское амбулаторное отделение Красногорское ПТО ГБУЗ МО «Красногорская ЦГБ № 1», Краснознаменский ПТК ГБУЗ МО «Краснознаменская ГП»	Заведующий филиалом «Истринский» Кондрашкина А.В. Врач-фтизиатр КДО ГБУЗ МО «МОКПТД», куратор территории Кузнецова Е.В.	2;4 вторник с 9-00 до 13-00 часов г. Москва, Пл. Борьбы д.11/1 (КДО)
Филиал «Одинцовский» ГБУЗ МО «МОКПТД», в том числе Наро-Фоминское диспансерное отделение ГБУЗ МО «Рузская ОБ», ПТК ГБУЗ МО «Можайская ЦРБ», ПТО Звенигородский ПТК ГБУЗ МО	Заведующий филиалом «Одинцовский» Сайдуллаев А.Х.А. Врач-фтизиатр КДО ГБУЗ МО «МОКПТД», куратор территории Кузнецова Е.В.	1;3 четверг с 9-00 до 13-00 часов г. Москва, Пл. Борьбы д.11/1 (КДО)

«Одинцовская ОБ»		
Филиал «Балашихинский» ГБУЗ МО «МОКПТД» Ногинское ПТО ГБУЗ МО «Ногинская ЦРБ», ПТО ГБУЗ МО Электростальская ЦГБ», ПТО Черноголовский ПТК Больница НЦЧ РАН	Заведующая филиалом Гончаренко Е.В. Врач-фтизиатр КДО ГБУЗ МО «МОКПТД», куратор территории Арутюнова М.А.	1;3 пятница с 9-00 до 13-00 часов г. Москва, Пл. Борьбы д.11/1 (КДО)
Филиал «Балашихинский» ГБУЗ МО «МОКПТД»	Заведующий стационаром Гончаров А.С.	Вторник с 09.00 до 13.00 ч; Пятница с 11.00 до 15.00 ч г. Мытищи, п. Здравница, ул. Дубки, д.7 (Клиника № 1)
Клиника № 1	Заведующая Клиникой № 1 врач-фтизиатр Багдасарян Т.Р.	Вторник с 09.00 до 13.00 ч; Пятница с 11.00 до 15.00 ч. г.о. Мытищи, п. Здравница, ул. Дубки, влд.7 (Клиника № 1)
Клиника № 2	Заведующая Клиникой № 2 Ильина О.С.	Вторник с 09.00 до 13.00ч; Пятница с 11.00 до 15.00 ч г. Мытищи, и. Здравница, ул. Дубки, д.7 (Клиника № 1)
ГБУЗ МО "Психиатрическая больница № 2" им. В.И. Яковенко	Ромашина О.В., врач-фтизиатр	Не реже 2 раз в месяц (по необходимости)

Приложение 4
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «15» января 2026 г. № 15/26

ЭПИКРИЗ БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗОМ (ВЗРОСЛОГО) ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА ЦВК

1. Ф.И.О_____
2. Адрес: 2.1 регистрации_____
2.2 фактического проживания_____
_____
3. Дата рождения_____
4. Вредные привычки: курение, алкоголизм, наркомания, токсикомания, вредных привычек нет.
5. Контакт: территориальный (семейный, бытовой), производственный, отсутствует (указать длительность контакта) _____
8. Профессиональная вредность_____
9. Дата направления в противотуберкулезное учреждение_____
10 Дата обращения в противотуберкулезное учреждение_____
10. Анамнез (с указанием конкретных дат)
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

10.1Данные объективного осмотра_____
_____
_____
_____
_____

10.2 Диагностические исследования (рентгенография, КТ, бронхоскопия, видеоторакоскопия) _____
_____
_____
_____
_____

10.2.1 Результата диаскинтеста, (IGRA-теста), дата постановки _____
10.2.2. Масса тела_____

Рентгенологическое обследование (вид исследования, дата, динамика): протоколы исследования прилагаются.
ЭКГ от_____: Ритм синусовый. ___ЧСС в 1 мин. Нормальное Горизонтальное Вертикальное положение ЭОС
Спирометрия от _____: Нарушений лёгочной вентиляции не выявлено. Нарушение лёгочной вентиляции по смешанному, рестриктивному, обструктивному типу.
ФБС от:
УЗИ органов брюшной полости от:

10.3 Микробиологические исследования

Микробиологические исследования					
Материал	Дата исследования	№ исследования	Результат б/скопии	Посев Bactec/ЛУ	Посев ППС/ЛУ

Результаты МГ-тестов		
Тест	Дата проведения	Результат

11. Диагноз и дата его установления (в соответствии с действующим приказом)

_____

_____

_____

Дата подачи извещения (089/У; 058/У) _____

12. Диагноз установлен туберкулезным учреждением по месту жительства, федеральным институтом, другим учреждением_____

_____

13. Лечение начато: в стационаре, амбулаторно, в санатории.

14. Режим ХТ _____

15. Специфическая терапия

Проведённая специфическая терапия			
Режим и дата его назначения	Фаза	Схема (с указанием суточной дозы)	Количество принятых доз
Переносимость лекарственных препаратов:			

Врач_____ _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Руководитель филиала (главный врач) или председатель подкомиссии ВК

_____ _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

дата заполнения « » _____20___год

МП

Заключение подкомиссии ВК_____

_____

_____

Приложение 5
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «15» января 2026 г. № 15/26

ЭПИКРИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА ЦВК ГБУЗ МО «МОКПТД»
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

от «_____» _____20_____ г.

Цель направления: подтверждение диагноза ТБ (в/в, рецидив), диагностика, контроль лечения, хирургическое лечение, снятие диагноза ТБ, определение эффективности лечения (абациллирование, закрытие полости распада, перевод в ШГДН).

Ф.И.О._____

Дата рождения (возраст)_____

Пол_____

Адрес регистрации_____

Детская организация_____

Семья_____

Вредные привычки_____

Наличие контакта с больными по туберкулезу_____

_____

БЦЖ рубец _____

Динамика проб Манту _____

_____

Результаты «Диаскинтеста», (IGRA-теста), _____

Сопутствующие заболевания _____

Состоит на ДУ у фтизиатра _____

Получил курс ХП (контролируемый) _____

_____

Санаторное лечение _____

Краткий анамнез заболевания _____

_____

_____

_____

_____

R-описание, КТ-описание

_____

_____

Бактериологическое
исследование_____

Диагноз при направлении

_____

_____

Врач_____ _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Руководитель филиала (главный врач) или председатель подкомиссии ВК

_____ _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

дата заполнения « »_____20___го

Заключение подкомиссии ВК_____

Приложение 6
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «15» января 2026 г. № 15/26

ПРОТОКОЛ № _____ ЗАСЕДАНИЯ ЦВК

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области
«Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер»

От _____ Врач докладчик: _____
Учреждение: _____
Цель представления на ЦВК:_____
Ф.И.О. пациента _____ Дата рождения _____
Адрес: _____
Диагноз при направлении (Код МКБ) _____
Диагноз сопутствующий (Код МКБ) _____

Данные бактериологического обследования

	Дата	Номер	Результат
Микроскопия			
Посев (4-5 при МЛУ/ШЛУ; 2-3 при ЛЧ)			
Молекулярно-генетические методы			

Данные лучевых методов обследования

	дата	результат
Рентгенография		
КТ		
Томография		

Масса тела_____

Устойчивость

Пути выявления (п\о; обращение)

Дата постановки диагноза ТБ_____ Дата начала лечения_____

Наличие ВИЧ – инфекции (Да; нет; нет данных); год выявления: _____; СД4 _____;
ВН _____АРВТ(да ;нет; нет данных)_____; (на период представления).

МБТ (–) / (+) CV (–) / (+)

Режим лечения_____ Схема лечения

Число принятых доз (ИФ)_____ Число принятых доз (ФП)_____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЦВК

Председатель ЦВК: Зам. председателя:
Члены комиссии:

Приложение 7
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «15» января 2026 г. № 15/26

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАСЕДАНИЙ ЦВК

№ п/п (№ протокола)	Дата ЦВК	Учреждение, Ф.И.О. врача	Цель представления на комиссию	Ф.И.О. больного, год рождения	Диагноз при направлении	Решение ЦВК	Состав	Подписи	Примечание

Приложение 8
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «15» января 2026 г. № 15/26

ПРОТОКОЛ РАЗБОРА ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА

1. Ф.И.О_____
2. Адрес регистрации_____
2.1 Адрес фактического проживания_____
_____
3. Дата рождения_____Пол_____
4. Дата смерти_____умер до года наблюдения, диагноз туберкулеза установлен на вскрытии, умер после_____лет наблюдения
5. Место смерти: в стационаре_____на дому, неизвестно (указать, где) _____
6. Место наблюдения: Район_____диспансер, отделение, кабинет, не наблюдался, иногородний, мигрант, неизвестно
7. Краткий анамнез заболевания :_____
_____
_____
_____
_____

8. Причина смерти: Клинический диагноз:
Основной_____
_____
Осложнение_____
Сопутствующий_____
_____
9.Патологоанатомический диагноз:
Основной_____
_____
_____
Осложнение_____
_____
Сопутствующий_____
_____
9.1 Гистологическое исследование: проведено, результат получен; проведено, результат не получен, не проведено, нет данных;
9. 2 Специалист, проводивший вскрытие: патологоанатом, судмедэксперт, не вскрыт;
10. Расхождение диагноза: да, нет;
10. 1 Причина расхождения диагноза: трудность диагностики, кратковременность пребывания в стационаре, недостаточное обследование, прочие_____
11. Сведения о пациенте:
Профессия _____
Вредные привычки: курение, алкоголизм, наркомания, токсикомания, вредных привычек нет.
ВИЧ-инфекция: да, нет
Контакт: территориальный (семейный, бытовой), производственный, отсутствует_____
Наличие инвалидности (по какому заболеванию): да, нет_____
Бактериовыделение: нет, выявлено методом _____, исследование не проводилось;
Выявлена устойчивость МБТ к ПТП: нет; да: МЛУ, пре-ШЛУ, ШЛУ_____;
Несвоевременное начало лечение: нет, позднее выявление, уклонение (отказ) от лечения, дефект наблюдения, нет данных.

Причина несвоевременного выявления: не проводилось обследование в группе риска, ФГ не обследован_более_____лет, своевременно не дообследован, диагностическая ошибка, пропуск патологии, нет данных.
Необходимое обследование: проведено в полном объеме; не в полном объеме, не проведено_____; нет данных.
Проведение показанного лечения: в полном объеме, не в полном объеме, не проводилось, не нуждался, нет данных.
Оценка ЦВК факторов, предопределивших смертельный исход:
1. В ЛПУ: нет; не проведено обследование по вине медработников; не проведено обследование по вине пациента; диагностические ошибки, пропуск патологии; не направлен в противотуберкулезное учреждение; не своевременно направлен в противотуберкулезное учреждение.
2. На этапе диспансерного наблюдения: нет; не состоял на учете; не своевременно выявлен (не выявлен); лечение не проводилось; на госпитализацию не направлен, на госпитализацию направлен несвоевременно; ошибки диагностики; прочие_____
3. В стационаре: нет; недостаточное, несвоевременное обследование; недостаточное, несвоевременное лечение, поздняя госпитализация, несвоевременный перевод в специализированное отделение; ошибка диагноза, прервал лечение;
4. Прочие социальные причины летального исхода: социально-неблагополучный пациент, мигрант, отказ от госпитализации, отказ от обследования;
Очаг смерти: Территориальный контакт_____Производственный_____
Число контактных: квартирный_____, территориальный_____, производственный_____, из них обследовано: квартирный_____, территориальный_____, производственный_____,
Из них выявлено больных туберкулезом: квартирный_____, территориальный_____, производственный_____
Заключительная дезинфекция: проведена_____(дата, номер наряда), не проведена (причины)_____

Врач_____ _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
Руководитель филиала (главный врач)_____ печать ЛУ
_____
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

дата заполнения « »_____22 ____год
Заключение подкомиссии ЦВК
_____
_____
_____
_____
_____

Председатель_____/_____Зам.председателя_____/_____

Члены комиссии:

Приложение 9
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «15» января 2026 г. № 15/26

1.Список умерших от туберкулеза

№	Ф.И.О.	Название муниципального образования	Дата взятия на ДУ	Дата смерти	Место смерти (мед.учреждение ПТД или ОЛС, на дому, на улице)	Гистология Дата, заключение	Окончательный диагноз	Примечание

2.Список расхождений диагнозов со службой ЗАГС

№	Ф.И.О.	Название муниципального образования	Дата взятия на ДУ	Дата смерти	Место смерти (мед. учреждение ПТД или ОЛС,	Диагноз по свидетельству о смерти	Дата получения сведений о смерти ПТД	Гистология, Дата, заключение	Окончательный диагноз	Дата подачи извещения 089/У	Примечание

Приложение 10
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «15» января 2026 г. № 15/26

ПЕРЕЧЕНЬ ФИЛИАЛОВ ГБУЗ МО «МОКПТД»
(с перечнем прикрепленных к ним городских округов),
ответственных кураторов территорий)

№ п\п	Наименование филиала	Наименование прикрепленных городских округов	Кураторы территорий, руководители филиалов, врачи – фтизиатры ГБУЗ МО «МОКПТД», КДО
1	филиал «Мытищинский» ГБУЗ МО МОКПТД (№ 1)	г.о. Мытищи г.о. Королев г.о. Фрязино г.о. Лосино-Петровск г.о. Щелково г.о. Пушкино г.о. Ивантеевка	Тушева И.А. Горлова С.В. Елуфимова Е.И.
2	филиал «Сергиево-Посадский» ГБУЗ МО МОКПТД (№ 2)	г.о. Сергиев Посад м.о. Дмитров г.о. Дубна г.о. Талдом	Трошин Н.А. Горлова С.В. Алиева И.А.
3	филиал «Орехово-Зуевский» ГБУЗ МО МОКПТД (№ 3)	г.о. Павловский Посад г.о. Орехово-Зуево м.о. Шатура	Гордеев А.А. Арутюнова М.А. Федорова С.В.
4	филиал «Балашихинский» ГБУЗ МО МОКПТД (№ 4)	г.о. Ногинск г.о. Электросталь г.о. Реутов г.о. Балашиха	Гончаренко Е.В. Арутюнова М.А. Мильянкова В.Р.
5	филиал «Люберецкий» ГБУЗ МО МОКПТД (№ 5)	г.о. Люберцы г.о. Дзержинский г.о. Котельники г.о. Лыткарино	Воробьёв В.Ю. Гриценко Е.Ю. Федорова С.В.
6	филиал «Коломенский» ГБУЗ МО МОКПТД (№ 6)	г.о. Коломна г.о. Озеры м.о. Луховицы м.о. Егорьевск г.о. Воскресенск м.о. Зарайск	Мануйлов Н.В. Гриценко Е.Ю., Елуфимова Е.И.
7	филиал «Подольский» ГБУЗ МО МОКПТД (№ 7)	г.о. Подольск г.о. Серпухов м.о. Чехов г.о. Протвино г.о. Пущино	Михайлова И.В. Гриценко Е.Ю. Мильянкова В.Р.
8	филиал «Домодедовский» ГБУЗ МО МОКПТД (№ 8)	г.о. Ступино г.о. Кашира м.о. Серебряные Пруды г.о. Домодедово г.о. Видное	Кондр Д.Е. Гриценко Е.Ю. Федорова С.В.

9	филиал «Истринский» ГБУЗ МО МОКПТД (№ 9)	г.о. Красногорск м.о. Истра г.о. Восход м.о. Волоколамск м.о. Лотошино м.о. Шаховская	Кондрашкина А.В. Кузнецова Е.В. Алиева И.А.
10	филиал «Одинцовский» ГБУЗ МО МОКПТД (№ 10)	г.о. Наро-Фоминск м.о. Можайск м.о. Руза г.о. Одинцово г.о. Краснознаменск г.о. Власиха	Сайдуллаев А-Х. А. Кузнецова Е.В. Алиева И.А.
11	филиал «Клинский» ГБУЗ МО МОКПТД (№ 11)	г.о. Клин г.о. Солнечногорск г.о. Долгопрудный г.о. Лобня г.о. Химки	Лукаш И.А. Горлова С.В., Кузнецова Е.В. Алиева И.А.
12	ГБУЗ «Раменская ЦРБ» (Филиал «Раменский» ГБУЗ МО «МОКПТД») (№ 12)	м.о. Раменский г.о. Бронницы г.о. Жуковский	Жердев А.В. Арутюнова М.А. Федорова С.В.

Приложение 11
к приказу ГБУЗ МО «МОКПТД»
от «15» января 2026 г. № 15/26

1. Отчет о деятельности ЦВК за _____ квартал 20___ года
Наименование учреждения _____

№ п/п	Цели направления на ЦВК	Рассмотрено случаев	Принято положительных решений
1.	Регистрация впервые выявленных больных ТОД		
2.	Регистрация впервые выявленных больных ТВЛ		
3.	Регистрация рецидива заболевания из III ГДН		
4.	Регистрация рецидива заболевания из ранее снятых, из архива		
5.	Регистрация больных с МЛУ МБТ, назначение IV РХТ		
6.	Регистрация больных с пре-ШЛУ МБТ, назначение V РХТ		
7.	Регистрация больных с ШЛУ МБТ, назначение V РХТ		
8.	Перерегистрация на IV РХТ через 90 доз (1,2,3 РХТ) при отрицательной клинико-рентгенологической динамике		
9.	Перерегистрация на IV РХТ через 60 доз (1,2,3 РХТ) при сохранении или появлении бактериовыделения		
10.	Перевод на ФП по IV РХТ		
11.	Перевод на ФП по V РХТ		
12.	Оценка эффективности лечения (абациллирование), лечение по 1,2,3 РХТ		
13.	Оценка эффективности лечения (закрытие полостей распада), лечение по 1,2,3 РХТ		
14.	Оценка эффективности лечения (абациллирование и закрытие полостей распада), лечение по 1,2,3 РХТ		
15.	Оценка эффективности лечения (абациллирование), лечение по 4-5 РХТ		
16.	Оценка эффективности лечения (закрытие полостей распада), лечение по 4-5 РХТ		
17.	Оценка эффективности лечения (абациллирование и закрытие полостей распада), лечение по 4-5 РХТ		
18.	Завершение основного курса лечения по IV РХТ		
19.	Завершение основного курса лечения по V РХТ		
20.	Разбор сложных и сорных случаев		

21.	Определение эффективности лечения через 150 доз. Лечение по 1,2,3 РХТ (более 150 доз) с наличием полости распада и бактериовыделения		
22.	Снятие диагноза		
23.	Перевод во 2Б ГДН		
24.	Перевод во 2А ГДН		
25.	Допуск к труду декретированных больных до завершения основного курса лечения		
26.	Прочие		
27.	Продолжение лечения или завершение лечения с использованием Bg, Dlm (через 180 дней)		
28.	Видеоконтролируемое лечение		
29.	Перевод в 3 ГДН		
30.	Дети – 6Б ГДН		
31.	Короткий курс лечения по 4-5 РХТ (9 месяцев)		

2. Отчет подкомиссии по разбору смертных случаев от туберкулеза

№ п/п	Функция ЦВК	Рассмотрено случаев	Принято решений
1.	Разбор смертных случаев		
1.1	Смерть от туберкулеза неизвестная диспансеру		
1.2	Смерть до года наблюдения		
1.3	Смерть больного туберкулезом от других причин		
2.	Расхождение клинического и патологоанатомического диагноза		
2.1	Расхождение 1 категории		
2.2	Расхождение 2 категории		
2.3	Расхождение 3 категории		
3.	Проведено патологоанатомических конференций		
3.1	На базе ГБУЗ МО «МОКПТД»		

3.2	В других медицинских учреждениях		
4.	Заменено свидетельств о смерти		